Etiquette patient

Date : .. / .. / 20..

URGENCE VITALE
en service d'hospitalisation conventionnelle

ACTIONS SIMULTANEES A ENTREPRENDRE AVANT L'ARRIVEE DE L'EQUIPE DE REANIMATION



Situation **aiguë** mettant en jeu le **pronostic vital** et nécessitant une **action immédiate**

Horaires

Par exemple (non exhaustif):
- ✓ Détresse respiratoire aiguë; hypoxémie sévère
- ✓ Coma brutal; modification brutale de l'état de conscience
- ✓ Etat de choc; bradycardie ou tachycardie sévère
- ✓ Suspicion d'anaphylaxie
- ✓ ….

.. H ..



Appeler la ligne URGENCE VITALE au …… ☐

.. H ..



Appeler des renforts ☐
Faire apporter le chariot d'urgence et le DSA ☐

Hypotension –Etat de choc
Position : surélever les membres inférieurs ☐
2ème VVP ☐
Hémocue si disponible ☐ ……

Détresse respiratoire
Position : ½ assise ☐

Grossesse manifeste
Position : décubitus latéral gauche ☐

Coma
Position : PLS ☐
Température ☐ ……
Glycémie ☐ ……..



Mesure rapprochée des paramètres vitaux (par ex, toutes les 3 min)
Maintien à jeun ☐
Glycémie ☐



Libérer les voies aériennes ☐
O2 Ouvert à 15 L/minute au masque à haute concentration ☐



VVP fonctionnelle :
- Vérifier VVP en place ou poser 1 VVP **AVEC** robinet ☐
- Base de NaCl 0,9% 500 mL pour purger la voie ☐

Etiquette patient

Date : .. / .. / 20..

ARRÊT CARDIAQUE
en service d'hospitalisation conventionnelle

ACTIONS SIMULTANEES A ENTREPRENDRE AVANT L'ARRIVEE DE L'EQUIPE DE REANIMATION

Horaires



Constat Arrêt Cardiaque ☐
- Pas de conscience
- Ne respire pas ou agonie (Gasp)
- Il n'est pas nécessaire de chercher le pouls !

.. H ..



Appeler la ligne URGENCE VITALE au …… ☐

.. H ..



Appeler des renforts ☐
Faire apporter le chariot d'urgence et le DSA ☐
Vérifier le système d'aspiration ☐



Débuter les Compressions Thoraciques (CT) ☐
5-6 cm de profondeur
Fréquence 100/120 min
Se relayer toutes les 2 minutes
NE JAMAIS S'ARRÊTER
Si grossesse manifeste, déplacement utérin vers la gauche

.. H ..



Allumer le défibrillateur (DSA), poser les patchs, et suivre les instructions ☐
(Arrêter ponctuellement les CT si demandé par le DSA)

.. H ..



Libérer les voies aériennes ☐
O2 Ouvert à 15 L/minute ☐
- O2 au masque à haute concentration ☐
- ou **BAVU :** 2 ventilations toutes les 30 compressions ☐



VVP fonctionnelle :
- Vérifier VVP en place ☐
- Poser 1 VVP **AVEC** robinet ☐
- Base de NaCl 0,9% 500 mL pour purger la voie ☐

Préparer deux seringues et les étiqueter :
- **Adrénaline PURE** 1mg/1ml (10 mL) ☐
- **Amiodarone PURE** 300 mg/6 ml ☐

ARRIVEE DE L'EQUIPE DE REANIMATION : ….H….

1

Etat clinique à l'arrivée :

- GCS …….
- Pupilles ……..
- Signe de localisation ……..

- PA …….. mmHg
- FC ……. bpm
- Arythmie ? ……..
- Marbrures ……..

- SpO2 ……. % sous ……..
- FR …….. / minute
- Signes de lutte ……..

- Température ……..
- HGT : ……..

- Autre :
  ……
  ……
  ……

2

Absence de CI à la réanimation ☐

SI ARRET CARDIAQUE

- **Confirmation AC** ☐
- **Rythme initial**
  - TV ☐
  - FV ☐
  - Asystolie ☐
  - Dissociation ☐
  - Autre ☐

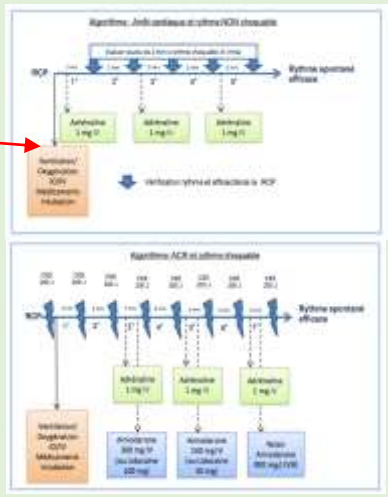
Compressions thoraciques
Relais toutes les 2 minutes

Envisager ECMO, tel : ……

Si RACS :

- Cardiologue pour coro : ……
- Radiologue pour scanner : ……

Si grossesse utérus à l'ombilic :
Extraction fœtale sur le lieu AC
Tel Obstétricien : ……
Tel Pédiatre : ……



3

Contrôle des voies aériennes

- IOT N° …..
- Avec laryngoscope ☐
  - ➢ Cormack …..
- Avec vidéolaryngoscope ☐
  - ➢ POGO …..
- Utilisation du mandrin d'Eischman ☐
- Nombre de laryngoscopies …..

- Inhalation macroscopique ☐

- Ventilation
  - BAVU ☐
  - Respirateur ☐

Réglages : FiO2 ……. VT……..
FR…… PEP …..

4

Enquête étiologique : terrain, événements récents ?

- ❑ Respiratoire :
  - ➢ Détresse respiratoire préalable ?
- ❑ Cardiaque :
  - ➢ Douleur thoracique ? Anomalie ECG ? Signes droits ?
- ❑ Neurologique :
  - ➢ Signe de localisation? Pupilles ?
- ❑ Métabolique :
  - ➢ Dyskaliémie connue ? Insuffisance rénale ? Syndrome de lyse ?
- ❑ Anaphylaxie :
  - ➢ Perfusion en cours ?

Heure																												
CONSTANTES																												
Aréactif (+/-)																												
Pouls (+/-)																												
EtCO2																												
PA																												
SpO2																												
TRAITEMENTS																												
CEE																												
Adré (mg)																												
Amiodarone (mg)																												

Bilan de la réanimation :

- Résumé médical de la prise en charge ……
  ……
  ……
- Etiologie retenue ? ……
  ……
  ……
  ……
- Destination du/de la patient(e) ……

- Heure RACS : ……
  - ➢ Durée No Flow …… minutes / Durée Low Flow : …… minutes

  ou
- Heure décision arrêt RCP : …… H ……
  - ➢ Heure du décès : ……H …… le ……/……/20….

Information des proches du patient :

- Nom du proche : ……
- Personne ayant délivré l'information : ……

Traçabilité :

- Leader médical (Réa) : ……
- Interne (Réa) : ……
- Infirmier(ère) : ……
- Aide soignant(e) : ……
- Autres professionnels impliqués : ……
  ……
  ……
- Cette feuille est scannée et intégrée au dossier informatique du /de la patient(e) ☐
- Ranger cette feuille dans le dossier médical papier ☐

Suites à donner :

- Problème rencontré lors de la PEC : ……
  ……
  ……
  ……
  ……
- Envisager déclaration « Evénement Indésirable Grave » et un débriefing de la prise en charge. Personne référente : ……